CM3 · LE RAISONNEMENT CLINIQUE

UE A1 — Sciences infirmières et raisonnement clinique | 1re année

Support de référence : Amélie PILLON, septembre 2026, promotion 2026–2029 (29 diapositives).

OBJECTIF DU COURS

Comprendre comment passer des **indices** aux **hypothèses**, puis au **jugement clinique**, afin de prioriser une prise en soins adaptée.

Le fil conducteur : raisonner, vérifier, décider

Le **raisonnement clinique** est le processus intellectuel qui relie des informations sur une personne, les connaissances professionnelles et la vérification d'hypothèses. Sa conclusion est un **jugement clinique** : les problèmes de santé retenus et argumentés.

SCHÉMA À SAVOIR

1. Indices et recueil de données → 2. Mobilisation des savoirs et hypothèses → 3. Recherche de données complémentaires → 4. Jugement clinique. Le raisonnement reste révisable en fonction de l'évolution de l'état de santé.

Plan de travail

1. Rechercher les indices et structurer le recueil.
2. Mobiliser les savoirs pour formuler des hypothèses.
3. Vérifier : problème réel ou problème potentiel ?
4. Formuler un jugement clinique et utiliser le modèle trifocal.
5. Distinguer anticipation et raisonnement hypothético-déductif.
6. Appliquer en stage, puis réviser avec le lexique et les exercices.

LÉGENDE COULEURS

Rouge = par cœur · **Bleu** = comprendre · **Vert** = stage · **Orange** = vigilance · **Jaune** = mémotechnique

1 · Chercher des indices : observer avant d’interpréter

PAR CŒUR — DÉFINITION

Un **indice** est une information observée, entendue, mesurée ou recueillie qui renseigne sur l’état de santé. C’est une **donnée brute** : « FR à 27/min » est un indice ; « détresse respiratoire » est une interprétation nécessitant une évaluation.

Le recueil est amorcé à l’entrée dans le service et **réactualisé à chaque contact**. Il vise à être assez large pour ne rien manquer, puis les informations sont triées selon leur utilité clinique du moment.

Où ?	Indices concrets
Observation directe	Teint, posture, respiration, expression du visage, agitation, repli, alimentation non consommée.
Parole et comportement	Douleur décrite, inquiétudes, propos, ton, silences, incohérences, communication non verbale.
Examen clinique infirmier	Paramètres vitaux, inspection, observation, palpation lorsque pertinente et maîtrisée.
Dossier et équipe	Antécédents, prescriptions, traitements, biologie, transmissions et observations des collègues.
Environnement	Obstacle à la marche, chambre encombrée, absence de sonnette accessible, entourage et autonomie.

Que faut-il trier ?

Une appendicectomie ancienne peut avoir peu de lien avec le séjour actuel, mais elle peut être pertinente devant certaines douleurs abdominales ou pour comprendre l’histoire du patient. **La pertinence dépend de la situation et de la question clinique.**

VIGILANCE — NE PAS CONFONDRE

Indice = fait ou parole exacte (« je n’arrive plus à respirer »). **Hypothèse** = explication possible (dyspnée d’origine à préciser). **Conclusion** = jugement clinique après recoupement. Ne pas transformer une impression en certitude.

MTEVD : organiser les macrocibles de recueil

Lettre	Rubrique	Exemples
M	Maladies	Motif d’hospitalisation, antécédents, symptômes, évolution.
T	Thérapeutiques	Traitements en cours, allergies connues, dispositifs, soins prescrits.
E	Environnement	Logement, entourage, aides, matériel, obstacles et ressources.
V	Vécu	Ressenti du patient, compréhension, préoccupations, habitudes.
D	Développement	Âge, autonomie, capacités, évolution et projet de vie.

2 · Mobiliser les savoirs, puis émettre des hypothèses

Les indices ne prennent sens qu'en étant rapprochés des savoirs : anatomie-physiologie, pathologies, pharmacologie, psychologie, besoins de la personne, expérience clinique et données probantes. Cette mise en lien permet de **formuler plusieurs hypothèses** plutôt qu'une interprétation unique.

EXEMPLE

Indice : une personne reste au lit et mange très peu. Hypothèses à explorer : fatigue liée à une maladie, douleur, nausées, tristesse, difficultés de déglutition, aide insuffisante au repas. Aucune hypothèse n'est confirmée sans recherche ciblée.

3 · Rechercher les informations manquantes

Pour **valider, infirmer ou hiérarchiser** une hypothèse, on recherche les données pertinentes : ce que rapporte le patient, les observations et paramètres, ses proches lorsque cela est approprié, l'équipe pluriprofessionnelle et le dossier de soins.

Hypothèse	Quelles données complémentaires ?
Douleur aiguë	Localisation, intensité, début, durée, facteurs aggravants ou calmants, échelle adaptée, signes associés.
Risque de chute	Antécédents de chute, marche et transferts, vigilance, hypotension orthostatique éventuelle, traitements, obstacles.
Risque d'altération cutanée	Mobilité, humidité, nutrition, état de peau, appuis, dispositifs et échelles utilisées dans le service.

Problème réel et problème potentiel

Problème réel	Problème potentiel = risque
Déjà présent. Il s'appuie sur des signes subjectifs (vécus/verbalisés) et/ou objectifs (observés/mesurés).	**Non survenu.** Des facteurs favorisants font craindre son apparition ; l'action est préventive.
Exemple : douleur déclarée et évaluée à 7/10.	Exemple : risque de chute chez une personne instable et sous traitement sédatif.
Question : « Quels signes prouvent que le problème existe ? »	Question : « Quels facteurs rendent ce risque plausible et prioritaire ? »

ATTENTION — IMPORTANT EN STAGE

Un patient peut avoir **simultanément** un problème réel et plusieurs risques. La présence d'un facteur de risque ne prouve pas une complication. À l'inverse, des signes d'alerte nouveaux peuvent faire requalifier un risque en problème avéré.

4 · Aboutir au jugement clinique

Le jugement clinique correspond aux **problèmes de santé retenus** au terme de l'analyse. Il doit être fondé sur les données, nuancé, actualisable et communiqué clairement à l'équipe. Il guide ensuite la priorisation, les objectifs de soins, les interventions et leur évaluation.

Exemple : « Douleur postopératoire présente, décrite par le patient et cotée 6/10 ; risque de chute lié à la faiblesse et à l'instabilité à la marche. »

Le modèle trifocal — classification utilisée par le formateur

Domaine	Ce qu'on y retrouve	Illustration
1. Problèmes médicaux	Signes et symptômes, maladie suspectée ou diagnostiquée, complications de pathologie ou de traitement.	Pneumonie diagnostiquée ; dyspnée à évaluer.
2. Problèmes potentiels	Risques favorisés par les traitements, les maladies ou les réactions humaines.	Risque de chute, de déshydratation, d'escarre.
3. Réactions humaines	Réponses physiques et psychologiques de la personne à la situation de santé.	Anxiété exprimée, douleur, perturbation du sommeil.

Le support annonce un cours ultérieur détaillant le modèle trifocal. Le présent cours conserve la classification telle qu'enseignée dans ce CM3. Des présentations pédagogiques du modèle peuvent varier.

POINT ESSENTIEL

Maladie diagnostiquée ≠ diagnostic infirmier. L'ESI observe et transmet les éléments, argumente les problèmes identifiés avec l'IDE et agit dans son champ de compétence et son niveau de formation. Ne pas poser seul un diagnostic médical.

5 · Deux formes de raisonnement utilisées ensemble

Anticipation	Analytique / inducto-hypothético-déductif
Prévoir un problème potentiel à partir d'une pathologie, d'une dépendance, d'un contexte ou d'un traitement.	Partir d'un indice ou faisceau d'indices, élaborer des hypothèses, rechercher des preuves et en déduire le problème le mieux étayé.
Ex. immobilisation → anticiper risque d'altération cutanée ; rechercher facteurs aggravants, agir en prévention.	Ex. fatigue + essoufflement → explorer plusieurs causes, mesurer les paramètres et alerter selon les signes.
Question : « Qu'est-ce qui pourrait arriver ? »	Question : « Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui le confirme ? »

MÉMO — 2 DÉMARCHES CONCOMITANTES

Anticiper pour prévenir les risques ; **analyser** pour comprendre les signes présents. Dans la réalité, les deux se combinent à chaque prise en soins.

6 · Le tableau de Raisonnement Clinique Partagé (RCP)

La diapositive 27 propose cinq colonnes. Ce tableau sert à rendre le cheminement visible et discutable avec le référent de stage et les autres professionnels.

INDICES	SAVOIRS	HYPOTHÈSES	À RECHERCHER	SOURCES
Patient dit « j'ai mal » ; grimace.	La douleur est un vécu subjectif ; évaluation standardisée.	Douleur actuelle à caractériser.	Intensité, localisation, début, durée, retentissement.	Patient, échelle, observation, dossier.
Personne instable au lever.	Instabilité favorise les chutes ; traitements possibles.	Risque de chute.	Autonomie, équilibre, vertiges, environnement, médication.	Observation, IDE, patient, dossier.

Le sigle RCP désigne ici « raisonnement clinique partagé ». Il peut signifier autre chose dans d'autres contextes ; toujours préciser le sens.

7 · Mise en situation : retour de chirurgie

Situation fictive : Mme L., 78 ans, après chirurgie de hanche, indique une douleur 6/10 ; elle se lève difficilement. Elle est fatiguée, sa sonnette est éloignée, les barrières du lit sont discutées avec l'équipe. Aucun patient réel n'est décrit.

Étape 1 — Recueil d'indices

Recueillir la douleur déclarée, mobilité, constantes selon la situation, état de vigilance, traitement prescrit, orientation, comportement et environnement du lit.

Étape 2 — Hypothèses

Réel : douleur actuelle, limitation de mobilité observée. **Potentiels :** risque de chute ; risque d'altération cutanée si immobilité prolongée ; autres risques selon données cliniques.

Étape 3 — Vérifications

Évaluer la douleur avec un outil adapté, demander ce qui gêne le mouvement, observer les transferts avec l'équipe, vérifier les horaires d'antalgiques et leurs effets, rechercher antécédents de chute et obstacles. Réévaluer.

Étape 4 — Jugement et actions

Transmettre à l'IDE le problème douloureux et les risques étayés. Sous encadrement, installer confortablement, mettre sonnette et affaires nécessaires à portée, sécuriser l'accompagnement des transferts, appliquer les prescriptions et surveillances relevant du cadre autorisé.

VIGILANCE

Si apparition d'une dyspnée, douleur thoracique, trouble majeur de vigilance, chute ou dégradation aiguë : **alerter immédiatement l'IDE / l'équipe compétente** et mettre en œuvre les gestes adaptés à sa formation. Ne pas retarder l'alerte pour compléter le tableau.

8 · Rôle IDE et place de l’ESI en stage

Auprès du patient	Surveillances / transmissions
Observer et écouter sans conclure trop vite. Accueillir la parole du patient, vérifier compréhension et consentement.	Tracer faits, mesures, paroles, heure, contexte et évolution ; distinguer fait de supposition.
Recueillir des paramètres vitaux et utiliser les échelles autorisées selon les consignes du service.	Surveiller douleur, état respiratoire, circulation, conscience, mobilité, hydratation et état cutané selon le contexte.
Repérer problèmes actuels et risques avec l’IDE ; hiérarchiser urgences.	Réévaluer après interventions, transmettre l’efficacité, les écarts et tout signe d’alerte.
Participer à la préparation et à la réalisation des soins selon ses compétences acquises et sous encadrement.	Garantir confidentialité, qualité des transmissions et continuité des soins.

TRANSMISSION CIBLÉE — EXEMPLE

Données : « douleur 6/10 », douleur à la mobilisation, grimace observée à 14 h. **Actions :** IDE prévenue ; installation adaptée ; antalgique administré par l’IDE selon prescription. **Résultat :** douleur réévaluée à 3/10 à 15 h. Exemple pédagogique, à adapter aux outils locaux.

9 · Les erreurs de raisonnement à éviter

• **Ancrage :** retenir la première hypothèse (« il est anxieux ») et ne plus vérifier les autres causes.

• **Confirmation :** ne rechercher que ce qui confirme son idée, en négligeant les signes contraires.

• **Interprétation hâtive :** noter « patient agressif » au lieu de décrire les propos et comportements observés.

• **Absence de réévaluation :** considérer un problème comme immuable alors que les signes évoluent.

• **Oubli des priorités :** se concentrer sur un problème mineur malgré un signe de gravité.

ASTUCE MNÉMOTECHNIQUE

I – S – C – J : **I**ndices → **S**avoirs → **C**ontrôle des hypothèses → **J**ugement. Et **MTEVD** pour ne pas oublier les dimensions du recueil.

10 · Lexique de stage

Terme	Définition simple
Indice	Donnée brute observée, mesurée, entendue ou recueillie.
Signe objectif	Élément que le professionnel observe ou mesure.
Symptôme subjectif	Expérience décrite par la personne, comme la douleur ou la nausée.
Hypothèse	Explication possible, à vérifier.
Problème réel	Problème de santé déjà présent et argumenté par des signes.
Problème potentiel	Risque de problème encore absent mais favorisé par certains facteurs.
Facteur prédisposant	Caractéristique qui augmente la vulnérabilité à un problème.
Facteur précipitant	Événement favorisant la survenue proche d'un problème.
Jugement clinique	Conclusion de l'analyse concernant les problèmes retenus.
Démarche clinique	Suite organisée : recueil, analyse, jugement, projet de soins et évaluation.
Macrocible	Synthèse structurée d'informations pertinentes sur une situation de soins.
MTEVD	Maladies – Thérapeutiques – Environnement – Vécu – Développement.
RCP (ce CM)	Raisonnement Clinique Partagé, tableau à cinq colonnes.
PTH	Prothèse totale de hanche (exemple du support).
Trifocal	Modèle décrivant trois domaines de problèmes : médicaux, risques, réactions humaines.

11 · Mini-quiz pour les évaluations

- 1. Une FR mesurée à 28/min est-elle un indice ou un jugement clinique ?
- 2. Citer les quatre grandes étapes du raisonnement clinique du formateur.
- 3. Quelle est la différence entre problème réel et problème potentiel ?
- 4. Développer les cinq lettres de MTEVD.
- 5. Citer les cinq colonnes du tableau RCP.
- 6. Dans quel domaine trifocal classe-t-on le risque de chute ?
- 7. Quelles informations compléter devant une douleur déclarée ?
- 8. Pourquoi les deux types de raisonnement sont-ils complémentaires ?

Corrigé

1. **Indice** : donnée mesurée. Son interprétation nécessite le contexte.
2. Indices ; mobilisation des savoirs et hypothèses ; informations complémentaires ; jugement clinique.
3. Réel = problème présent et objectivé/verbalisé ; potentiel = événement redouté, pas encore survenu.
4. Maladies ; Thérapeutiques ; Environnement ; Vécu ; Développement.
5. Indices ; Savoirs mobilisés ; Hypothèses ; Éléments à rechercher ; Sources d’information.
6. Domaine 2, les problèmes potentiels, selon le support du formateur.
7. Intensité, lieu, début, durée, facteurs déclenchants/soulageants, retentissement, signes associés.
8. L’anticipation prévient les risques ; l’analyse vérifie et explique les problèmes actuels.

Pour l’oral : la phrase à retenir

30 SECONDES

« J’observe des indices, je les mets en lien avec mes savoirs pour proposer des hypothèses, je recherche les informations manquantes pour les vérifier, puis je formule un jugement clinique que je réévalue. Je distingue les problèmes réels des risques à prévenir. »

12 · Sources et repères de validité

Source pédagogique principale : Amélie PILLON, « Le raisonnement clinique », promotion IFSI 2026–2029, septembre 2026, 29 diapositives. Progression et classification trifocale reprises de ce support.

Cadre de formation : arrêté du 20 février 2026 relatif au diplôme d'État d'infirmier, publié au JO du 25 février 2026, notamment annexe III (domaine A : sciences infirmières et raisonnement clinique ; UE A1) et annexe I (compétences).

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000053568913

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000053570499/

Cadre professionnel : Code de la santé publique, article R. 4311-3 dans sa version en vigueur depuis le 30 juin 2026 (décret n° 2025-1306 du 24 décembre 2025). Il décrit notamment la consultation infirmière, le recueil et l'analyse des données cliniques et l'élaboration des diagnostics infirmiers.

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000053197682

NOTE DE MÉTHODE

Les définitions et les étapes sont issues du support. Les exemples de stage, le lexique enrichi, les questions et les alertes sont des **ajouts pédagogiques** visant à faciliter l'apprentissage, et ne constituent pas une transcription du diaporama.

Document de formation — version du 15 octobre 2026. Ne remplace pas les procédures de l'établissement, les prescriptions médicales ni l'encadrement de stage.